Клинические рекомендации

Острый ларингит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J04.0** — Острый ларингит **J04.2** — Острый ларинготрахеит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 01.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/309_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 5

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Физикальное обследование 5

3.3 Ларингоскопия 6

3.4 Общий (клинический) анализ крови 7

3.5 Микробиологическое исследование гнойного отделяемого 7

3.6 Пульсоксиметрия 7

3.7 Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием 7

4. Лечение 7

4.1 Неосложнённый ларингит 7

4.2 Антибактериальная терапия у взрослых 9

4.3 Антибактериальная терапия у детей 9

4.4 Флегмонозный, абсцедирующий, инфильтративный ларингит, хондроперихондрит гортани 10

4.5 Стеноз гортани 11

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 11

5.1 Показания к госпитализации 11

6. Источник и актуальность 12

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 12

1. Основные положения

- Ларингоскопия показана всем пациентам. **С 12 лет** гортань осматривают гортанным зеркалом; если у ребёнка младшего возраста такой осмотр невозможен, прибегают к видеофиброринофаринголарингоскопии.
- При неосложнённом ларингите на фоне вирусной инфекции и длительности симптомов **менее 10 дней** антибактериальная терапия не назначается.
- При дисфонии показан полный голосовой покой **на 1–2 суток** с последующим ограничением голосовой нагрузки; из рациона исключаются острая, солёная, горячая и холодная пища, необходим отказ от алкоголя и курения.
- Показания к **срочной госпитализации** в стационар с отделением интенсивной терапии и возможностью интубации трахеи:
  1. флегмонозный ларингит;
  2. абсцедирующий ларингит;
  3. инфильтративный ларингит;
  4. хондроперихондрит гортани.
- Ларингит без стеноза гортани на фоне острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) не требует госпитализации. При дыхательной недостаточности **выше I степени** необходима экстренная госпитализация.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Острый ларингит (ОЛ) представляет собой острое воспаление слизистой оболочки гортани длительностью до 3 недель. При длительности заболевания более 3 недель необходимо исключить его аутоиммунную природу.

Абсцедирующий, или флегмонозный, ларингит является формой острого ларингита с образованием абсцесса, чаще на язычной поверхности надгортанника или на черпалонадгортанных складках. Заболевание проявляется резкой болью при глотании и разговоре с иррадиацией в ухо, повышением температуры тела, плотным инфильтратом в тканях гортани. Острый хондроперихондрит гортани характеризуется острым воспалением хрящей гортани с вовлечением в процесс надхрящницы и окружающих тканей.

Острый подскладочный ларингит (круп) характеризуется воспалением в подголосовом пространстве с отёком слизистой оболочки под голосовыми складками, затруднением дыхания и одышкой. Заболевание встречается у детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет.

2.2 Этиология

Как правило, острый ларингит является проявлением острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ): гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции, при которых воспалительный процесс затрагивает также слизистую оболочку полости носа и глотки, а в ряде случаев бронхи и лёгкие. Воспаление гортани может быть также продолжением катарального воспаления полости носа или глотки.

Основными возбудителями бактериального ларингита являются S. pneumoniae (20–43%) и H. influenzae (22–35%); достаточно часто высеваются Moraxella catarrhalis (2–10%), различные стрептококки и стафилококки, значительно реже Neisseria, Corynebacterium и другие микроорганизмы.

Помимо инфекции, причинами ларингита являются наружная и внутренняя травма шеи и гортани, в том числе ингаляционная, инородное тело, аллергия, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, повышенная голосовая нагрузка. К предрасполагающим факторам относятся хронические заболевания бронхов и лёгких, полости носа и околоносовых пазух, сахарный диабет, гипотиреоз, заболевания желудочно-кишечного тракта, хроническая почечная недостаточность, нарушение разделительной функции гортани, употребление алкоголя, курение, лучевая терапия в анамнезе.

2.3 Классификация

По форме

1. катаральный;
2. отёчный;
3. флегмонозный (инфильтративно-гнойный, в том числе инфильтративный и абсцедирующий);
4. острый подскладочный.

По этиологии

1. вирусный;
2. бактериальный;
3. грибковый;
4. специфический.

2.4 Клиническая картина

Основные симптомы

1. нарушение голоса, от лёгкой дисфонии до афонии;
2. острая боль в горле;
3. кашель;
4. возможны затруднение дыхания и ухудшение самочувствия.

Заболевание начинается внезапно, на фоне удовлетворительного состояния или небольшого недомогания. При катаральном ларингите температура тела нормальная или субфебрильная; фебрильная лихорадка, как правило, свидетельствует о вовлечении нижних дыхательных путей или о переходе катарального процесса во флегмонозный.

Инфильтративная и абсцедирующая формы

1. выраженная боль в горле;
2. нарушение глотания, в том числе жидкости;
3. повышенное слюноотделение;
4. вынужденное положение головы;
5. выраженная интоксикация;
6. нарастающие признаки стеноза гортани.

Общее состояние тяжёлое. При отсутствии адекватного лечения возможно развитие флегмоны шеи, медиастинита, сепсиса, абсцедирующей пневмонии, стеноза гортани.

Клиническая картина острого стеноза гортани не зависит от его причины и определяется степенью сужения:

1. шумное дыхание с нарушением ритма;
2. западение надключичных ямок и втяжение межрёберных промежутков на вдохе;
3. запрокидывание головы;
4. гортань опускается на вдохе и поднимается на выдохе.

При неполной обструкции возникает стридор. При преобладании отёка дыхание свистящее, при преобладании гиперсекреции хриплое, клокочущее. В терминальной стадии стеноза дыхание становится всё более тихим вследствие уменьшения дыхательного объёма.

При абсцессе надгортанника на фоне острой боли вначале развивается невозможность глотания, а по мере прогрессирования процесса затруднение дыхания. Голосовая щель может закрыться очень быстро, что требует экстренных мероприятий для спасения жизни пациента.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливают на основании анамнеза, жалоб, данных физикального обследования и ларингоскопии.

Жалобы

1. изменение голоса;
2. боль при глотании;
3. кашель;
4. повышение температуры тела.

Признаки тяжёлых форм

1. ухудшение общего состояния;
2. боль при глотании даже жидкости;
3. фебрильная лихорадка;
4. повышенное слюноотделение;
5. нарушение дыхания;
6. болезненность шеи и гортани при пальпации, нарушение подвижности хрящей гортани;
7. вынужденное положение головы и шеи.

3.2 Физикальное обследование

Показания

1. подозрение на острый ларингит: осмотр оториноларинголога, врача общей практики (семейного врача) или педиатра.

Степень дыхательной недостаточности (основной признак: одышка)

1. I степень: одышка при физической нагрузке;
2. II степень: одышка при незначительной нагрузке (неспешная ходьба, умывание, одевание);
3. III степень: одышка в покое.

Стадии стеноза гортани

Стадия	Признаки
Компенсация	Одышка в покое отсутствует, возникает при ходьбе; просвет гортани сужен на треть.
Субкомпенсация	Инспираторная одышка при нагрузке с участием вспомогательной мускулатуры, втяжение межрёберных промежутков, яремной и надключичных ямок, стридор, бледность кожных покровов; артериальное давление нормальное или повышенное; просвет гортани сужен наполовину и более.
Декомпенсация	Дыхание поверхностное, частое, резко выраженный стридор, вынужденное положение сидя, максимальные экскурсии гортани, лицо бледно-синюшное, потливость, акроцианоз, пульс частый, нитевидный, артериальное давление снижено; просвет гортани щелевидный.

Стадия	Признаки
Асфиксия	Дыхание прерывистое или отсутствует, голосовая щель резко сужена, сердечная деятельность угнетена, пульс частый, нитевидный, часто не определяется, кожные покровы бледно-серые; потеря сознания, экзофтальм, непроизвольные мочеиспускание и дефекация, остановка сердца.

При быстром нарастании стеноза состояние пациента тяжелее, поскольку компенсаторные механизмы не успевают развиться. Это учитывается при решении вопроса об экстренном хирургическом вмешательстве.

3.3 Ларингоскопия

Показания

1. все пациенты с острым ларингитом.

Непрямая ларингоскопия гортанным зеркалом обязательна при осмотре оториноларингологом пациентов 12 лет и старше как в поликлинике, так и в стационаре. У детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях поликлиники её выполнение часто невозможно из-за эмоциональной лабильности и выраженного глоточного рефлекса; в таких случаях проводится видеофиброринофаринголарингоскопия.

Ларингоскопия позволяет определить характер процесса, его локализацию, уровень, протяжённость и степень сужения дыхательных путей.

Диагностические признаки острого ларингита

1. гиперемия и отёк слизистой оболочки гортани с усилением сосудистого рисунка;
2. голосовые складки розовые или ярко-красные, утолщены;
3. голосовая щель при фонации овальной или линейной формы, со скоплением мокроты;
4. при подскладковом ларингите валикообразное утолщение слизистой оболочки под голосовыми складками.

Признаки по формам

1. катаральная форма: изменения преимущественно на голосовых складках, в межчерпаловидном или подскладковом пространстве; расширенные поверхностные сосуды, слизистый или слизисто-гнойный секрет, усиливающий охриплость;
2. отёчная форма: вся слизистая оболочка гортани гиперемирована и отёчна, смыкание голосовых складок неполное;
3. геморрагический ларингит на фоне гриппа или ОРВИ: кровоизлияния в слизистую оболочку, от петехий до небольших гематом.

Налёты

1. белый или беловато-жёлтый фибринозный налёт: переход в более тяжёлую, фибринозную форму;
2. налёт серого или бурого цвета: возможна дифтерия;
3. налёт у взрослого, не связанный с интубационной травмой: срочная дифференциальная диагностика с системными заболеваниями и туберкулёзом.

Инфильтративный ларингит, хондроперихондрит, абсцесс надгортанника

1. поражённый отдел гортани значительно инфильтрирован, гиперемирован, увеличен в объёме, малоподвижен, часто покрыт фибринозными налётами; в зоне формирования абсцесса просвечивает гной;
2. при тяжёлой форме и хондроперихондрите гортань болезненна при пальпации, хрящи малоподвижны, кожа над гортанью может быть инфильтрирована и гиперемирована;
3. абсцесс надгортанника: шаровидное образование на язычной поверхности надгортанника с просвечивающим гноем, выраженная боль и нарушение глотания.

3.4 Общий (клинический) анализ крови

Показания

1. оценка общего состояния и выявление воспалительной реакции.

Диагностические признаки

1. лейкоцитоз;
2. повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ).

При флегмонозном ларингите при госпитализации необходимо комплексное клинико-лабораторное обследование всех пациентов.

3.5 Микробиологическое исследование гнойного отделяемого

Посев на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителя и определением его чувствительности к антибиотикам.

Показания

1. гнойное отделяемое: выбор адекватной терапии.

При поступлении в стационар проводится стандартное лабораторное обследование.

3.6 Пульсоксиметрия

Показания

1. дети младшего и дошкольного возраста: оценка степени дыхательной недостаточности и определение показаний к кислородотерапии.

3.7 Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием

Показания

1. подозрение на гнойные осложнения (в стационаре);
2. затруднение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями гортани.

КТ целесообразна в условиях стационара при подозрении на гнойные осложнения или при затруднении дифференциальной диагностики с другими заболеваниями гортани. Если у ребёнка с признаками стеноза выполнение КТ невозможно, в сомнительных случаях проводится рентгенография шеи в прямой и боковой проекциях.

---

4. Лечение

Тактика лечения определяется формой и тяжестью воспалительного процесса.

4.1 Неосложнённый ларингит

1. Ограничение голосовой нагрузки (исключение крика и шёпота **не менее 2 дней**) и лечебно-охранительный режим при дисфонии любой степени.

   При дисфонии рекомендуется полный голосовой покой на 1–2 суток с последующим ограничением любой голосовой нагрузки. Из рациона исключаются острая, солёная, горячая и холодная пища, спиртные напитки; необходим отказ от курения.
2. При катаральном ларингите на фоне ОРВИ повышенное потребление жидкости не рекомендуется.

   Польза обильного питья сомнительна, тогда как повышенная в период заболевания секреция антидиуретического гормона способствует задержке жидкости.
3. При фебрильной лихорадке противовоспалительные и жаропонижающие препараты (дозы в таблице ниже).

   Детям с температурой тела выше 39–39,5 °C, помимо лекарственных средств, показаны физические методы охлаждения: раскрытие ребёнка и обтирание водой температуры 25–30 °C.

4. Детям противокашлевые и отхаркивающие препараты рутинно не назначают, за исключением случаев мучительного кашля.

   Перед назначением противокашлевых средств необходимо исключить состояния, при которых подавление кашля опасно и которые требуют специфического лечения, например бронхиальную обструкцию, а у детей также острый обструктивный ларингит (круп).
5. Местная противовоспалительная терапия: вливания лекарственных препаратов в гортань и ингаляции.

   Для вливаний в гортань чаще всего используются антисептики из группы производных хинолина и четвертичных аммониевых соединений. Раствор подогревается до температуры тела и вливается по каплям, в объёме до 2 мл. Детям вливания в гортань не проводятся в связи с угрозой ларингоспазма.
6. Небулайзерные ингаляции аэрозолей средней и низкой дисперсности (препараты в таблице ниже).

   Продолжительность ингаляции, как правило, составляет 10 минут, интервал между ингаляциями различных препаратов около 30 минут. При наличии корок в гортани ингаляции начинаются с муколитика.
7. При вирусной инфекции и длительности симптомов **менее 10 дней** антибактериальная терапия не назначается.
8. Системные антибиотики назначают при сохранении симптомов **в течение 10 дней** и при осложнённом течении.

   Взрослым назначение антибиотика целесообразно при затяжном течении ларингита (10 дней и более), а также при выраженной инфильтрации голосовых складок и экссудации.

   Взрослым антибиотик подбирается эмпирически и назначается внутрь: амоксициллин 500–1000 мг 3 раза в сутки 5–10 дней; амоксициллин с клавулановой кислотой 875/125 мг 2 раза в сутки 5–10 дней; цефиксим 400 мг 1 раз в сутки 5–10 дней; цефдиторен 400 мг 1 раз в сутки 10 дней; кларитромицин 250–500 мг 2 раза в сутки 6 дней; джозамицин 1000 мг 2 раза в сутки 5–10 дней.
9. При аллергических заболеваниях (аллергический ринит, крапивница, поллиноз, аллергический конъюнктивит) системные антигистаминные препараты.
10. Противогрибковые препараты только после подтверждения кандидоза: взрослым флуконазол 100 мг в сутки или итраконазол 100 мг 1 раз в сутки **15 дней**.
11. Консультация физиотерапевта.

Жаропонижающие препараты

Препарат	Доза
Парацетамол	До 60 мг/кг в сутки. Детям — 10–15 мг/кг каждые 6 часов, не более 60 мг/кг в сутки.
Ибупрофен	До 30 мг/кг в сутки. Детям — 7,5 мг/кг каждые 6–8 часов, не более 30 мг/кг в сутки.

Препараты для ингаляций

Препарат	Доза
Ацетилцистеин (раствор для инъекций и ингаляций)	Ингаляционно по 1 ампуле (3 мл) 1–2 раза в сутки, 5–7 дней.
#Будесонид	Ингаляционно 1000 мкг 1–2 раза в сутки, курс 5–8 процедур.

Возможно применение готовых аптечных смесей на основе растительных препаратов с учётом противопоказаний и возраста: масла листьев эвкалипта прутовидного, а также 5–10% отваров цветков ромашки, листьев шалфея, травы тимьяна ползучего (чабреца), цветков календулы, листьев подорожника. Такие ингаляции могут быть тёплыми и холодными; продолжительность первой ингаляции составляет 1–2 минуты, последующих 5–10 минут.

Антигистаминные препараты

Препарат	Доза
Лоратадин, цетиризин	Детям 3–12 лет с массой тела более 30 кг — 10 мг 1 раз в сутки, менее 30 кг — 5 мг 1 раз в сутки; взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки.
Левоцетиризин	Детям 2–6 лет — 1,25 мг 2 раза в сутки; старше 6 лет и взрослым — 5 мг 1 раз в сутки.
Дезлоратадин	От 6 до 12 месяцев — 1 мг, с 1 года до 5 лет — 1,25 мг, 6–11 лет — 2,5 мг, взрослым и детям старше 12 лет — 5 мг; кратность приёма 1 раз в сутки.

При дисфонии на фоне острого ларингита рекомендацией предусмотрено включение в терапию комплексных гомеопатических препаратов для уменьшения выраженности нарушений голоса. Приведённый в рекомендации препарат зарегистрирован по показанию «ларингиты различной этиологии» и применяется у взрослых и детей старше 6 лет с первых дней заболевания на 6 дней.

4.2 Антибактериальная терапия у взрослых

Препарат	Показание	Доза внутрь
Амоксициллин	Препарат выбора	500 мг 3 раза в сутки; при факторах риска устойчивости пневмококка — 1000 мг 3 раза в сутки.
Амоксициллин + клавулановая кислота	Альтернативный препарат; при факторах риска продукции бета-лактамаз	500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки.
Цефиксим	Альтернатива	400 мг 1 раз в сутки.
Цефдиторен	Альтернатива	400 мг; в таблице кратность зачёркнута, в тексте указано 1 раз в сутки.
Кларитромицин	Аллергия на бета-лактамы	250–500 мг 2 раза в сутки.
Джозамицин	Аллергия на бета-лактамы	1000 мг 2 раза в сутки.

Факторами риска устойчивости пневмококка к бета-лактамам являются приём антибиотиков в предшествующие 3 месяца, наличие в семье детей дошкольного возраста, посещающих детские учреждения, проживание в «закрытых» учреждениях. Амоксициллин с клавулановой кислотой предпочтителен при риске инфицирования возбудителем, продуцирующим бета-лактамазы (H. influenzae, S. aureus, M. catarrhalis): при бронхиальной астме, сахарном диабете, хроническом бронхите, иммуносупрессии, в возрасте старше 65 лет, при неэффективности предшествующего лечения амоксициллином.

> В тексте рекомендации цефдиторен назначается по 400 мг 1 раз в сутки в течение 10 дней, тогда как в таблице 1 кратность его приёма зачёркнута целиком («2 раза в сутки 1 раз в сутки»).

4.3 Антибактериальная терапия у детей

В тексте рекомендации детям предлагаются: амоксициллин 40–60 или 80–90 мг/кг в сутки 5–7 дней; амоксициллин с клавулановой кислотой до 3 месяцев — 30 мг/кг в сутки в 2 приёма, с 3 месяцев — 25 мг/кг в сутки в 2 приёма или 20 мг/кг в сутки в 3 приёма, 5–10 дней; цефиксим в суспензии 8 мг/кг в сутки в 1–2 приёма 5–10 дней; цефтриаксон с 15 дней до 12 лет 20–80 мг/кг 1 раз в сутки, при массе тела более 50 кг — дозы для взрослых; кларитромицин 7,5–15 мг/кг в сутки в 2 приёма не более 14 дней; джозамицин 50 мг/кг в сутки в 2–3 приёма 5–10 дней; тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат внутримышечно 10 дней.

Препарат	Показание	Доза
Амоксициллин	Препарат выбора	Внутрь 40–60 мг/кг в сутки; при факторах риска устойчивости пневмококка — 80–90 мг/кг в сутки.
Амоксициллин + клавулановая кислота	Альтернатива	Внутрь, суспензия 4:1 (125 мг + 31,25 мг в 5 мл или 250 мг + 62 мг в 5 мл) в 3 приёма каждые 8 часов; доза «45–60 мг/кг/сутки в 2–3 приёма» в таблице зачёркнута.
Цефиксим	Альтернатива	8 мг/кг в сутки 1 раз в сутки.
Цефтриаксон	Альтернатива	С 15 дней до 12 лет — 20–80 мг/кг 1 раз в сутки; при массе тела более 50 кг — дозы для взрослых.
Кларитромицин	Аллергия на бета-лактамы	Внутрь 7,5 мг/кг в сутки в 2 приёма, не более 1000 мг в сутки.
Джозамицин	Аллергия на бета-лактамы	50 мг/кг в сутки в 2–3 приёма.
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат	При невозможности применения бета-лактамов и макролидов	До 2 лет — по 125 мг 2 раза в сутки; 3–6 лет — по 250 мг 2 раза в сутки; 7–12 лет — по 250 мг 3 раза в сутки; взрослым — по 500 мг 2–3 раза в сутки; 10 дней.

> Детские дозы в тексте и в таблице 2 не совпадают. Для кларитромицина в тексте указана «для детей старше 12 лет разовая доза» 7,5–15 мг/кг/сут, в таблице 7,5 мг/кг/сут в 2 приёма. Для амоксициллина с клавулановой кислотой в тексте приведена доза 20–30 мг/кг/сут, в таблице доза 45–60 мг/кг/сут зачёркнута и указана только суспензия в 3 приёма. Цефиксим в тексте назначается в 1–2 приёма, в таблице 1 раз в сутки. Для тиамфеникола возрастные группы «до 2 лет» и «от 3 до 6 лет» не включают детей от 2 до 3 лет.

4.4 Флегмонозный, абсцедирующий, инфильтративный ларингит, хондроперихондрит гортани

1. Обязательная срочная госпитализация в учреждение с отделением интенсивной терапии и возможностью интубации трахеи (раздел «Показания к госпитализации»).
2. Антибактериальная терапия в стационаре начинается эмпирически с учётом региональной резистентности основных возбудителей; после улучшения состояния возможен переход на приём антибиотика внутрь (ступенчатая терапия). Препараты и дозы в таблице ниже.
3. Промывание полости абсцесса растворами антисептиков: 0,01% раствором бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммония хлорида моногидрата или гидроксиметилхиноксалиндиоксидом.
4. При дисфагии и тяжёлых формах: дезинтоксикационная терапия, коррекция гиповолемии, глюкокортикостероиды, парентеральное питание.
5. При осложнённых формах хирургическое лечение.

Препарат	Детям	Взрослым (осложнённый флегмонозный ларингит)
Амоксициллин + клавулановая кислота	С 3 месяцев внутривенно 25/5 мг/кг каждые 6–8 часов, 5–10 дней	Внутривенно 1,2 г 3 раза в сутки, 7–10 дней
Цефотаксим	Внутримышечно или внутривенно 150 мг/кг в сутки в 4 введения	Внутривенно 2 г 3 раза в сутки, 7–10 дней
Цефтриаксон	С 15 дней до 12 лет внутримышечно или внутривенно 20–80 мг/кг 1 раз в сутки, 5–10 дней	Внутримышечно или внутривенно 2 г 1 раз в сутки, 7–10 дней

Препарат	Детям	Взрослым (осложнённый флегмонозный ларингит)
Цефепим	При тяжёлом флегмонозном ларингите и осложнениях в отделении реанимации: при массе тела более 40 кг — 2 г каждые 12 часов, до 40 кг — 50 мг/кг каждые 12 часов, 7–10 дней	—
Меропенем	В тех же условиях: от 3 месяцев до 12 лет — 10–20 мг/кг 3 раза в сутки, при массе тела более 50 кг — доза для взрослых, 5–10 дней	—
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат	До 2 лет — 125 мг 2 раза в сутки, 3–6 лет — 250 мг 2 раза, 7–12 лет — 250 мг 3 раза в сутки	500 мг 2–3 раза в сутки, 10 дней

4.5 Стеноз гортани

1. Для профилактики стеноза: консервативная противовоспалительная терапия; дестенозирующая терапия: парентеральное введение глюкокортикоидов.
2. Детям с декомпенсированным стенозом гортани: неотложная интубация трахеи.
3. При невозможности интубации: трахеостомия или коникотомия.

> В комментарии о дестенозирующей терапии фраза оборвана: указана доза «60–120 мг», однако не указано, к какому глюкокортикоиду она относится и предназначена ли она для взрослых или для детей.

При неосложнённом остром ларингите хирургическое лечение не требуется.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Пациентам голосоречевых профессий после перенесённого острого ларингита показано наблюдение оториноларинголога до полного восстановления голосовой функции.

Сроки нетрудоспособности у таких пациентов продлеваются до полного восстановления голоса. Неосложнённый ларингит разрешается за 7–14 дней, разрешение инфильтративных форм занимает более 14 дней.

Профилактика хронизации воспалительного процесса гортани заключается в своевременном лечении острого ларингита, повышении сопротивляемости организма, лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и инфекций верхних и нижних дыхательных путей, отказе от курения и соблюдении голосового режима.

Пациенту рекомендуется ограничить голосовую нагрузку, исключить горячую, холодную и острую пищу, спиртные напитки, курение и паровые ингаляции, постоянно увлажнять воздух в помещении с помощью увлажнителя; в составе комплексного лечения в рекомендации упоминаются противовирусные препараты.

> В разделе 7 и в памятке для пациента паровые ингаляции запрещены, тогда как в разделе 3.1 ингаляции отваров трав допускаются «тёплыми». Там же рекомендованы противовирусные препараты, однако в разделе о лечении такая рекомендация отсутствует.

5.1 Показания к госпитализации

Пациенты с острым ларингитом без стеноза гортани на фоне ОРВИ не нуждаются в госпитализации. Госпитализации подлежат все пациенты с осложнённым течением.

Обязательной **срочной госпитализации** в учреждение с отделением интенсивной терапии и возможностью интубации трахеи подлежат пациенты с осложнёнными и тяжёлыми формами:

1. флегмонозный ларингит;
2. абсцедирующий ларингит;
3. инфильтративный ларингит;
4. хондроперихондрит гортани.

Показанием к экстренной госпитализации является острая дыхательная недостаточность выше I степени.

Пациента выписывают при:

1. регрессе воспалительных изменений;
2. отсутствии дыхательной недостаточности;
3. отсутствии осложнений.

При неосложнённом ларингите прогноз благоприятный. При осложнённых формах со стенозом гортани решающее значение для сохранения жизни пациента имеют своевременная специализированная помощь и хирургическое лечение.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острый ларингит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 01.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	`309_2` · открыть текст КР ↗
Разработчики	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Союз педиатров России
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Для цефдиторена в тексте указано 400 мг 1 раз в сутки, в таблице 1 кратность зачёркнута целиком.
- Детские дозы кларитромицина, амоксициллина с клавулановой кислотой и цефиксима в тексте и в таблице 2 различаются; для кларитромицина «разовая доза» приведена в мг/кг/сут и «для детей старше 12 лет».
- Для тиамфеникола глицината ацетилцистеината не указана доза для детей от 2 до 3 лет: выделены только группы «до 2 лет» и «от 3 до 6 лет».
- В комментарии о дестенозирующей терапии не назван глюкокортикоид, к которому относится доза «60–120 мг».
- Раздел 7 запрещает паровые ингаляции и рекомендует противовирусные препараты, тогда как раздел 3.1 допускает тёплые ингаляции и не содержит рекомендации о противовирусных препаратах.